



**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І
«ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

ID здобувача / Student ID									

Прізвище / Surname									

Варіант / Variant 43

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО
ІСПИТУ**

КРОК 3

**Спеціальність
«СТОМАТОЛОГІЯ»**

1. Жінка віком 44 роки скаржиться на напади самовільного болю в ділянці верхньої щелепи ліворуч, що тривають по 2-3 год, посилюються вночі та від дії холодних подразників. Біль турбує протягом двох днів. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 25 зуба каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину. Зондування болісне по всьому дну. ЕОД=30 мкА. Який імовірний діагноз?

- А. Гострий гнійний пульпіт
- В. Гострий дифузний пульпіт
- С. Гострий глибокий карієс
- Д. Невралгія трійчастого нерва
- Е. Гострий серозний періодонтит

2. Що у конструкції ортодонтичного апарата має ознаки елементів функціонально-направляючої дії?

- А. Гвинт для розширення
- В. Вестибулярна дуга
- С. Похила площина
- Д. Рукоподібні пружини
- Е. Базис апарата

3. Чоловік віком 67 років скаржиться на біль під базисом повного знімного протеза на нижній щелепі під час жування. Повні знімні протези на верхню та нижню щелепу виготовлені місяць тому. Протези фіксуються добре, під час розмови та вживання їжі стійкі. Після зняття повного знімного протеза на нижній щелепі в ділянці верхівки альвеолярного гребеня спостерігається рівномірна точкова гіперемія. Під час дотику до ділянок гіперемії відзначається незначна болючість. Яка тактика лікаря-стоматолога-ортопеда в цьому разі?

- А. Провести корекцію базису протеза з внутрішньої поверхні
- В. Відполірувати внутрішню поверхню базису протеза
- С. Провести клінічне перебазування базису протеза
- Д. Провести лабораторне перебазування базису протеза
- Е. Провести корекцію оклюзійно-артикуляційних контактів

4. Під час профілактичного огляду дівчини віком 17 років лікар-стоматолог виявив утворення надлишкової емалі округлої форми діаметром 3 мм у пришийковій ділянці 24 зуба, що відокремлене від основної емалі зуба пластом цементу. З анамнезу відомо: це утворення було на зубі з моменту прорізування. Який імовірний діагноз?

- А. Гіперплазія емалі
- В. Гіпоплазія емалі
- С. Недосконалий амелогенез
- Д. Гіперцементоз
- Е. Недосконалий дентиногенез

5. Що є основним недоліком під час вико-

ристання методики зняття одноетапного двошарового відбитка?

- А. Пришвидшена усадка
- В. Відсутність відвідних каналів
- С. Укорочений час полімеризації
- Д. Відсутність адгезії до ложки
- Е. Відсутність явища тиксотропності

6. Жінка віком 30 років перебуває на лікуванні з діагнозом: фурункул лівої щоки. Раптово стан пацієнтки погіршився — з'явився головний біль, підвищення температура тіла до 39°C, збільшився набряк щоки, з'явився щільний інфільтрат у вигляді тяжа в ділянці внутрішнього кута ока. Яке ускладнення, найімовірніше, розвинулося в цьому разі?

- А. Абсцес щоки
- В. Тромбофлебіт лицевих вен
- С. Флегмона щоки
- Д. Карбункул щоки
- Е. Бешиха

7. Батьки дев'ятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота дитини. Під час огляду виявлено значну кількість м'якого зубного нальоту. Які поверхні зубів треба зафарбувати для визначення індексу Федорова-Володкіної з метою гігієнічного навчання дитини та наочного прикладу необхідності ретельного чищення зубів?

- А. Вестибулярну поверхню 16, 11, 26, 31 зубів та язикову поверхню 36, 46 зубів
- В. Вестибулярну поверхню 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів
- С. Язикову поверхню 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів
- Д. Оральну поверхню 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів
- Е. Вестибулярну поверхню 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів

8. Батьки чотирирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у передньому зубі верхньої щелепи дитини, зміну його положення, неможливість відкушування їжі. Декілька годин тому хлопчик отримав травму обличчя. Об'єктивно спостерігається: конфігурація обличчя не змінена, на шкірі нижньої губи та підборідді садно, слизова оболонка нижньої губи травмована, рухомість 51 зуба I ступеня, невелике зміщення його положення вестибулярно в сагітальному напрямку. На рентгенограмі визначається рівномірне розширення періодонтальної щілини 51 зуба. Яка тактика лікаря після обробки рани?

- А. Реплантація 51 зуба
- В. Ендодонтичне лікування 51 зуба
- С. Професійна гігієна порожнини рота
- Д. Видалення 51 зуба
- Е. Динамічне спостереження

9. Жінка віком 58 років скаржиться на відсутність 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47 зубів. Зуби, що залишилися, мають рухомість I ступеня. На ортопантомограмі у ділянці 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубів спостерігається резорбція альвеолярного відростка в межах $1/3$ висоти міжзубних перетинок. Яку ортопедичну конструкцію доцільно запропонувати пацієнтці?

- A. Частковий знімний пластинковий протез
- B. Напівкоронкову шину
- C. Бюгельну шину-протез
- D. Шину на скловолоконній стрічці
- E. Шину Ельбрехта

10. Лікарю-стоматологу потрібно провести візуальний огляд коронкових частин зубів пацієнта. Які мають бути умови для проведення точної оцінки?

- A. Зуби мають бути чистими та сухими
- B. Зуби мають бути чистими, вологими та досліджуватися під джерелом світла
- C. Зуби мають бути чистими та вологими
- D. Зуби мають бути сухими та досліджуватися під джерелом світла
- E. Зуби мають бути чистими, сухими та досліджуватися під джерелом світла

11. Батьки семирічної дівчинки звернули увагу на наявність у неї множинних білих блискучих плям на вестибулярних поверхнях передніх зубів обох щелеп. Дитина народилася і проживає у зоні ендемічного флюорозу. Установлено діагноз: плямиста форма флюорозу зубів. Прийом яких препаратів для дівчинки є доцільним для індивідуальної профілактики прогресування флюорозу в зимово-весняний період?

- A. Цинку
- B. Магнію
- C. Фтору
- D. Кальцію
- E. —

12. Дівчинка віком 15 років скаржиться на естетичний недолік зубів. Під час огляду на вестибулярній поверхні верхніх та нижніх різців виявлено наявність численних крейдоподібних смужок у вигляді штрихів, які не втрачали блиск під час висушування. Після обстеження встановлено діагноз: флюороз зубів. Дівчинка народилася в місцевості з підвищеним вмістом фтору в питній воді. У який період формування тканин зуба відбулася негативна дія надлишку фтору?

- A. Прорізування зубів
- B. Формування періодонта
- C. Дентиогенезу
- D. Формування кореня
- E. Амелогенезу

13. Сімнадцятирічний юнак скаржиться на незвичний вигляд ясен. Об'єктивно спосте-

рігається: маргінальний край вестибулярної поверхні ясен блідо-рожевого кольору, валикоподібно потовщений. Ясенні сосочки округлої форми, перекривають коронкові частини всіх зубів майже на $1/3$ їх висоти, кровоточивість відсутня. На рентгенограмі верхньої та нижньої щелеп патологічних змін не виявлено. Який імовірний діагноз?

- A. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- B. Фіброматоз ясен
- C. Хронічний катаральний гінгівіт
- D. Загострення катарального гінгівіту
- E. Генералізований пародонтит I ступеня

14. Чотирнадцятирічний хлопчик скаржиться на випадіння пломби та наявність порожнини в зубі нижньої щелепи ліворуч. Об'єктивно спостерігається: 36 зуб зруйнований на $1/2$, порожнина зуба відкрита, на вустах кореневих каналів залишки пломбувального матеріалу, термопроба негативна, зондування, перкусія безболісні. На рентгенограмі виявлено розширення періодонтальної щілини коренів 36 зуба. Установіть діагноз.

- A. Хронічний гранулюючий періодонтит
- B. Хронічний гранулематозний періодонтит
- C. Хронічний гангренозний пульпіт
- D. Хронічний фіброзний періодонтит
- E. Хронічний фіброзний пульпіт

15. Чоловік віком 35 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність новоутворення на нижній губі. Об'єктивно на незмінній червоній облямівці нижньої губи ліворуч спостерігається вузол діаметром 0,6 см, напівкулястої форми, щільної консистенції, що підвищується над рівнем червоної облямівки та вкритий сірими лусочками. Пальпація безболісна. Який попередній діагноз?

- A. Папілома
- B. Кератоакантома
- C. Бородавчастий передрак
- D. Передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи
- E. Піогенна гранульома

16. Хлопець віком 18 років скаржиться на виражений біль у роті під час ковтання, погіршення апетиту, загальну слабкість, підвищення температури тіла до $39,1^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно спостерігається: на м'якому піднебінні, мигдаликах, піднебінних дужках та в ретромолярних ділянках розташовані дрібні згруповані пухирці з серозним та серозно-геморагічним вмістом. Деякі пухирці були розкриті з утворенням ерозій із яскраво-червоним дном, не вкриті фібринозним нальотом. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, слабко болісні під час пальпації. Який попередній діагноз?

- А. Багатоформна ексудативна еритема
- В. Рецидивний герпетичний стоматит
- С. Гострий герпетичний стоматит
- Д. Інфекційний мононуклеоз
- Е. Герпетична ангіна

17. Під час стоматологічного огляду восьмирічної дівчинки виявлено наявність множинних білих блискучих плям на вестибулярних поверхнях різців обох щелеп. Дитина народилася та проживає в зоні ендемічного флюорозу. Лікар-стоматолог встановив діагноз: флюороз зубів. Який метод первинної профілактики є найефективнішим у цьому разі?

- А. Споживання продуктів із підвищеним вмістом заліза
- В. Споживання кисломолочних продуктів
- С. Споживання продуктів із підвищеним вмістом клітковини
- Д. Споживання продуктів із підвищеним вмістом кальцію
- Е. Усунення підвищеного вмісту фтору в питній воді

18. Дівчина віком 16 років скаржиться на естетичний недолік зубів у вигляді множинних білих плям. Об'єктивно спостерігається: на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці ікол та різців верхньої та нижньої щелеп крейдоподібні тьмяні плями з нерівними контурами. Рівень гігієни задовільний. Після обстеження встановлено діагноз: гострий початковий карієс фронтальної групи зубів. Який метод лікування буде найдоцільнішим?

- А. Препарування і пломбування композитним матеріалом
- В. Піццерофосфат кальцію всередину
- С. Інфільтрація Icon
- Д. Професійна гігієна
- Е. Препарування і пломбування СІЦ

19. Жінка віком 32 роки скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: ясна верхньої та нижньої щелеп гіперемовані з ціанотичним відтінком, набряклі. Пародонтальні кишені — до 3,5 мм. На ортопантограмі виявлено резорбцію міжальвеолярних перетинок до 1/3 їх висоти. Установіть діагноз.

- А. Генералізований пародонтит II ступеня
- В. Генералізований пародонтит I ступеня
- С. Пародонтоз II ступеня
- Д. Гіпертрофічний гінгівіт
- Е. Пародонтоз I ступеня

20. У чоловіка віком 80 років спостерігаються множинні елементи ураження шкіри: висипи, напшарування, бляшки, зроговіння, ерозії тощо. Яке новоутворення шкіри пацієнта може трансформуватись у меланому?

- А. Базаліома
- В. Кератоакантома
- С. Папілома
- Д. Невус
- Е. Гемангіома

21. Пацієнту віком 45 років за результатами клінічного та рентгенологічного обстеження встановлено діагноз: амелобластома тіла нижньої щелепи праворуч. Діагноз підтверджено пункційною біопсією. Який метод хірургічного лікування доцільно застосувати в цьому разі?

- А. Екскохлеацію
- В. Цистотомію
- С. Вишкрібання пухлини в межах здорових тканин
- Д. Цистектомію
- Е. Резекцію нижньої щелепи

22. Батьки трирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність на зубах дитини естетичних дефектів. Під час обстеження на вестибулярній поверхні різців та ікол виявлено чашоподібні заглиблення в емалі овальної форми. Емаль під час зондування щільна, гладенька, блискуча, у ділянці дна дефекту спостерігається аплазія. Яку форму системної гіпоплазії виявлено в пацієнта?

- А. Плямисту
- В. Ерозивну
- С. Змішану
- Д. Апластичну
- Е. Борозенчасту

23. Дівчині віком 19 років за ортодонтичними показаннями рекомендовано видалення нижніх третіх молярів. Під час проведення знеболювання пацієнтка поскаржилася на слабкість та втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, вологі, АТ — 110/70 мм рт. ст., пульс ниткоподібний. Через 10 секунд дівчина отямилася. Який невідкладний стан, найімовірніше, розвинувся в пацієнтки?

- А. Напад стенокардії
- В. Колапс
- С. Асфіксія
- Д. Непритомність
- Е. Напад епілепсії

24. До лікаря-стоматолога звернулися батьки шестирічної дівчинки зі скаргами на припухлість підщелепної ділянки ліворуч у дитини. З анамнезу відомо, що дитина хворіє на гемофілію. Об'єктивно спостерігається: 74 зуб зруйнований на 2/3, реакція на термічні подразники негативна, перкусія слабкоболісна, слизова оболонка перехідної складки в ділянці 74 зуба гіперемована, згладжена, болісна під час пальпації. На рентгенограмі виявлено нерівномірну резорбцію коренів 74 зуба, деструкція міжкореневої перетинки та кортикальної пла-

стинки над фолікулом 34 зуба. Укажіть тактику лікаря в цьому разі.

- A. Динамічне спостереження
- B. Видалення 74 зуба в умовах стаціонару
- C. Ендодонтичне лікування 74 зуба
- D. Видалення 74 зуба
- E. Періостотомія, видалення 74 зуба

25. Чоловік віком 32 роки скаржиться на кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: помірна кількість зубних відкладень, незначний набряк та застійна гіперемія маргінального краю ясен обох щелеп. З анамнезу відомо: пацієнт чистить зуби нерегулярно, курить. Під час проведення пародонтального скринінг-тесту порушення зубоюсенного з'єднання не виявлено. Лікар-стоматолог після огляду порожнини рота скерував пацієнта на рентгенологічне дослідження. Які рентгенографічні ознаки можуть свідчити про початок розвитку пародонтиту?

- A. Зниження висоти міжкоміркових перегородок
- B. Остеосклероз альвеолярного відростка
- C. Остеопороз верхівок міжкоміркових перегородок
- D. Остеопороз альвеолярного відростка
- E. Розширення періодонтальної щілини в ділянці апексу

26. Дванадцятирічний хлопчик скаржиться на головний біль, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 39°C , наявність болючих виразок у порожнині рота. З анамнезу відомо: у пацієнта алергічні реакції на деякі лікарські засоби. Під час огляду на гіперемованій набряклій слизовій оболонці губ, щік та язика виявлено великі ерозії, що вкриті фібринозним нальотом. Червона облямівка губ у тріщинах із кров'яними кірочками. Спостерігаються ураження слизової оболонки носа та кон'юнктиви. Який попередній діагноз має встановити лікар-стоматолог-терапевт?

- A. Багатоформна ексудативна еритема
- B. Синдром Стівенса-Джонсона
- C. Виразково-некротичний стоматит
- D. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- E. Гострий герпетичний стоматит

27. У план комплексного лікування ортодонтичної патології включено компакто-стеотомію. З якою метою запропоновано цю маніпуляцію?

- A. Для видалення надкомплектних зубів
- B. Підготовка до фіксації брекет-системи
- C. Скорочення терміну лікування
- D. Альтернатива апаратного лікування
- E. Адаптації ортодонтичного апарату

28. Жінка віком 26 років скаржиться на

біль, відчуття розпирання та збільшення нижньої губи. Об'єктивно спостерігається: нижня губа набрякла із явищами застійної гіперемії, гіпертрофії та розширенням усть дрібних слинних залоз, із яких виділяється секрет світлого кольору. Червона облямівка губ суха, виявлено поодинокі лусочки. Який вид хейліту можна діагностувати в цьому разі?

- A. Актинічний
- B. Ексфолюативний
- C. Метеорологічний
- D. Пандулярний
- E. Алергічний

29. Пацієнтці віком 54 роки з частковою відсутністю зубів I класу за Кеннеді на верхній щелепі проводиться виготовлення бюгельного протеза. Одним із лабораторних етапів виготовлення є проведення паралелометрії. Що визначають на цьому етапі?

- A. Межі базису протеза
- B. Трансверзальну криву
- C. Відносну паралельність зубів
- D. Оклюзійну криву
- E. Центральне співвідношення щелеп

30. Жінка віком 49 років скаржиться на новоутворення у правій підщелепній ділянці, що виникло місяць тому після гострого тонзиліту, підвищення температури тіла до $37,2^{\circ}\text{C}$. Проводилася протизапальна терапія. Об'єктивно спостерігається: у правій підщелепній ділянці кулясте новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, діаметром до 2 см. Шкіра в кольорі не змінена. З протоки слинної залози виділяється прозора слина. Який імовірний діагноз?

- A. Хронічний лімфаденіт
- B. Атерома
- C. Аденома слинної залози
- D. Хронічний сіалоаденіт
- E. Слинокам'яна хвороба

31. Чоловік віком 25 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий біль у зубі нижньої щелепи праворуч під час вживання солодкого. Об'єктивно спостерігається: на медіальній поверхні 46 зуба каріозна порожнина, що не сполучається з пульповою камерою зуба, виповнена світлим, розм'якшеним дентином. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія зуба безболісна. БОД — 11 мкА. Термопроба позитивна, реакція зникає відразу після припинення дії подразника. Який імовірний діагноз?

- A. Гострий глибокий карієс
- B. Гострий середній карієс
- C. Гіперемія пульпи
- D. Хронічний фіброзний періодонтит
- E. Хронічний фіброзний пульпіт

32. Батьки одинадцятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на рецидив діастеми після проведеного ортодонтичного лікування. Об'єктивно спостерігається: діастема I типу 3 мм, вуздечка верхньої губи коротка, щільна, у вигляді тяжу прикріплюється до ясенного сосочка. Яка причина рецидиву?

- A. Шкідливі звички
- B. Не проведено френулопластику
- C. Порушення носового дихання
- D. Неналежа гігієна
- E. Незбалансоване харчування

33. Пацієнту на прийомі в лікаря-стоматолога діагностовано генералізований пародонтит II ступеня тяжкості, хронічний перебіг. З анамнезу відомо: протезування клапана серця. Лікар планує проведення первинного пародонтологічного лікування, що передбачає насамперед видалення над- та під'ясенних зубних відкладень. Які групи препаратів мають бути призначені пацієнту для профілактики розвитку ендокардиту?

- A. Знеболювальні засоби системної дії
- B. Протизапальні засоби місцевого застосування
- C. Знеболювальні засоби місцевої дії
- D. Антибіотики для системного застосування
- E. Антибіотики для місцевого застосування

34. Після атипового видалення 48 зуба в пацієнта спостерігається парастезія в ділянці правої половини нижньої губи та підборіддя. Під час обстеження на ЕОД виявлено зниження електростимулюємії пульпи зубів нижньої щелепи праворуч. Який імовірний діагноз?

- A. Оперізувальний лишай
- B. Невралгія правого нижньоальвеолярного нерва
- C. Гострий остеомієліт тіла нижньої щелепи
- D. Неврит правого нижньоальвеолярного нерва
- E. Альвеоліт

35. Чоловік віком 21 рік скаржиться на помірний біль у горлі, підвищення температури тіла, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: м'яке піднебіння та піднебінні дужки набряклі, слабо гіперемовані з ціанотичним відтінком. На мигдаликах виявлено сірувато-білі плівки нальоту, щільно спаяні з поверхнею, зняття яких супроводжується кровотечею. Який збудник, найімовірніше, буде виявлено під час мікроскопії матеріалу з вогнища ураження?

- A. Стафілокок
- B. Мікобактерія Коха
- C. Фузоспірілярний симбіоз
- D. Паличка Лесффлера
- E. Гемолітичний стрептокок

36. Чоловік віком 58 років скаржиться на сухість та печіння у порожнині рота, що посилюються під час вживання їжі. З анамнезу відомо: пацієнт хворіє на цукровий діабет та невроз, що виник три місяці тому. Об'єктивно спостерігається: СОПР гіперемована, набрякла, спинка язика вкрита білуватим нальотом, який частково легко знімається. Слина тягнеться нитками за шпателем. Укажіть імовірний діагноз.

- A. Десквамативний глосит
- B. Хронічний кандидоз
- C. Лейкоплакія
- D. Червоний плоский лишай
- E. Глосидинія

37. Батьки одинадцятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний недолік. Під час зовнішньоротового обстеження відхилень не виявлено. Під час внутрішньоротового обстеження встановлено: співвідношення перших молярів за першим класом Енгля праворуч та за другим класом Енгля ліворуч, 13 зуб розташований вище оклюзійної площини з дефіцитом місця 5 мм, центральна лінія між верхніми центральними різцями зміщена в лівий бік. За даними аналізу телерентгенограми кут SNA=82°, SNB=80°. Якою буде тактика лікування цієї патології?

- A. Видалення 14 зуба та переміщення 13 зуба в зубний ряд
- B. Диспансерне спостереження до 16 років
- C. Створення місця та переміщення 13 зуба в зубний ряд
- D. Видалення 13 зуба
- E. Видалення 14 та 24 зубів, очікування саморегуляції

38. У пацієнта віком 23 роки під час профілактичного огляду лікарем-стоматологом виявлено недорозвиненість горбів перших молярів, зуби мають конусовидну форму. З анамнезу відомо: спадковий сифіліс. Якому діагнозу відповідає описана клінічна картина?

- A. Зуби Пфлюгера
- B. Зуби Фурнье
- C. Недосконалий амелогенез
- D. Флюороз зубів
- E. Зуби Іетчинсона

39. У чоловіка віком 70 років порушена конфігурація обличчя через наявність горбистої пухлини з чіткими межами, що локалізується в м'яких тканинах лівої половини обличчя, губах, порожнині рота, альвеолярному відростку. Шкіра над пухли-

ною змінена в кольорі, пігментована, пухлинні вузли безболісні, рухомі, м'які під час пальпації. Установіть попередній діагноз.

- А. Лімфангіома
- В. Піогенна гранульома
- С. Лімфогранулематоз
- Д. Нейрофіброматоз
- Е. Гемангіома

40. Підліток віком 15 років скаржиться на постійну кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання їжі. Об'єктивно спостерігається: набряк, гіперемія та ціаноз ясен у фронтальній ділянці нижньої щелепи, ясенні сосочки набряклі та легко кровоточать під час зондування. Наявні над'ясенні щільні зубні нашарування. Вкажіть додатковий метод обстеження для встановлення остаточного діагнозу.

- А. Стоматоскопія
- В. Телерентгенографія
- С. Реопародонтографія
- Д. Електроодонтодіагностика
- Е. Рентгенографія

41. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулися батьки дванадцятирічної дівчинки зі скаргами на неправильне положення передніх зубів та естетичний недолік усмішки. Під час обстеження виявлено скупченість зубів верхньої та нижньої щелеп із дефіцитом місця 3 мм. Який ступінь тяжкості патології в цьому разі?

- А. Легкий
- В. Тяжкий
- С. Дуже тяжкий
- Д. Середній
- Е. —

42. У пацієнта виявлено протрузію зубів у фронтальному відділі верхньої щелепи. До якої групи аномалій прикусу належить ця патологія?

- А. Вертикальних
- В. Супраоклюзійних
- С. Трансверзальних
- Д. Транспозиційних
- Е. Сагітальних

43. Батьки однорічної дитини звернулися до дитячого лікаря-стоматолога зі скаргами на появу висипань у порожнині рота, кровоточивість ясен, підвищення температури тіла до $38,8^{\circ}\text{C}$ у дитини та явища загальної інтоксикації: блідість шкірних покривів, слабкість. Об'єктивно спостерігається: ясна гіперемовані та набряклі, кровоточать від дотику. На слизовій оболонці губ та язика виявлено численні болісні дрібні ерозії округлої та овальної форми, діаметром 2-3 мм, укриті білим нальотом. Наявне злиття елементів. Слизова оболонка навколо ерозій набрякла, гіперемова-

на. На шкірі навколо ротової порожнини виявлено пухирці з каламутним вмістом. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені та болючі. Який період захворювання в дитини?

- А. —
- В. Інкубаційний
- С. Продромальний
- Д. Клінічного одужання
- Е. Розпалу хвороби

44. Жінка віком 60 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на значну сухість у порожнині рота. З анамнезу відомо, що жінка чотири роки хворіє на системний червоний вовчак, кератокон'юнктивіт та хронічний паренхіматозний паротит. Для якого синдрому характерні ці симптоми?

- А. Костена
- В. Робена
- С. Мелькерсона-Розенталя
- Д. Бехчета
- Е. Шегрена

45. Чоловік віком 54 роки протягом 24-х днів перебував на стаціонарному лікуванні в щелепно-лицевому відділенні через перелом нижньої щелепи. Після зняття шин відчув обмежене відкривання рота, незначний біль у ділянці скронево-нижньощелепного суглоба. Об'єктивно спостерігається: відстань між ріжучими краями центральних різців під час максимального відкривання рота становить 2,5 см. Яке ускладнення після перелому нижньої щелепи, найімовірніше, розвинулося?

- А. Несправжній суглоб
- В. Неправильно зрощений перелом
- С. Контрактура нижньої щелепи
- Д. Мікростомія
- Е. Анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба

46. Чоловіку віком 45 років було проведено операцію гайморотомії з подальшою місцевою пластикою співустья через комірку видаленого 25 зуба. На третю добу пацієнт відмічає закладеність носа та припинення виділень з пазухи. Яке лікування треба провести в цьому разі?

- А. Промити верхньощелепну пазуху через співустья з коміркою 25 зуба
- В. Здійснити повторну пластику співустья місцевими тканинами
- С. Призначити судинозвужувальні засоби та фізіотерапевтичні процедури
- Д. Здійснити повторну гайморотомію з тампонадою пазухи
- Е. Промити верхньощелепну пазуху через нижній носовий хід

47. У пацієнта віком 40 років, який перебуває на лікуванні в щелепно-лицевому ста-

ціонарі з діагнозом: флегмона дна порожнини рота — спостерігається погіршення загального стану, підвищення температури до 40°C . Лікар визначив позитивні симптоми Герке, Іванова, Равич-Щербо. Яке ускладнення, ймовірно, розвинулося в пацієнта?

- A. Сепсис
- B. Тромбофлебіт
- C. Медіастиніт
- D. Токсемія
- E. Тромбоз

48. Юнак віком 16 років звернувся до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду. Об'єктивно спостерігається: зуби інтактні, але тісно розміщені, ясенні сосочки незначно збільшені та гіперемовані. Велика кількість м'якого зубного нальоту. Лікарем діагностовано хронічний катаральний гінгівіт та проведено професійне чищення зубів із гігієнічним навчанням. Що доцільно рекомендувати для очищення апроксимальних поверхонь зубів цьому пацієнту?

- A. Зубні йоржики
- B. Зубочистки
- C. Міжзубні стимулятори
- D. Ротовий іригатор
- E. Нитки-флоси

49. До лікаря-стоматолога-хірурга звернувся пацієнт віком 23 роки після видалення 47 зуба зі скаргами на біль, що пульсує та іррадіює у вухо, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до $37,6^{\circ}\text{C}$, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка в ділянці видаленого зуба набрякла та гіперемована, комірка заповнена гнійно-некротичними масами, укрита нальотом брудно-сірого кольору. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації. Який імовірний діагноз?

- A. Альвеоліт лунки 47 зуба
- B. Паратонзиллярний абсцес
- C. Остеомієліт нижньої щелепи
- D. Гострий гнійний періодонтит 47 зуба
- E. Неврит коміркового нерва

50. Жінка віком 59 років скаржиться на ниючий біль у ділянці лівого СНЩС, скутість у суглобі зранку, відчуття закладеності в лівому вусі. Під час внутрішньоротового огляду виявлено часткову адентію. На рентгенограмі СНЩС спостерігається: суглобова щілина місцями різко звужується, суглобовий горбик згладжений, глибина суглобової ямки зменшена, суглобові поверхні нерівні. Яку патологію СНЩС можна діагностувати в цьому разі?

- A. Больову дисфункцію
- B. Анкілоз
- C. Хронічний артрит
- D. Гострий артрит
- E. Артроз

51. У пацієнта віком 20 років діагностовано утруднене прорізування 48 зуба. Лікар визначив абсолютне показання для видалення після проведення рентгенологічного методу дослідження, де виявив півмісяць Васмунда. Які рентгенологічні ознаки цього утворення?

- A. Резорбція кісткової тканини в ділянці гілки нижньої щелепи
- B. Косе положення, медіальний нахил нижнього третього моляра
- C. Резорбція кісткової тканини позаду коронки нижнього третього моляра
- D. Резорбція кісткової тканини в ділянці біфуркації коренів нижнього третього моляра
- E. Резорбція кісткової тканини на верхівці кореня нижнього третього моляра

52. Після обстеження пацієнтки віком 33 роки встановлено діагноз: гострий середній карієс 17 зуба I класу за Блєком. Під час виконання реставрації використано рідкотекучий композиційний матеріал як основний. Які недоліки цього виду пломбувального матеріалу?

- A. Нерентгенконтрастність
- B. Низький рівень естетичності
- C. Висока еластичність
- D. Значна усадка
- E. Висока токсичність

53. Чоловік віком 29 років скаржиться на погіршення загального стану, підвищення температури тіла до $37,3^{\circ}\text{C}$, головний біль, гнильний запах із рота, неможливість вживання їжі через біль та кровоточивість ясен протягом трьох днів. Пацієнт працює будівельником, тиждень тому зазнав значного переохолодження. Об'єктивно спостерігається: пацієнт у стані апатії, шкіра обличчя бліда з крапельками поту, гіперсаливація, регіонарний лімфаденіт, ясна гіперемовані, набряклі, різко болісні, укриті біло-сірим нальотом та легко кровоточать. Установлено попередній діагноз: виразково-некротичний гінгівіт. Що відіграло вирішальну роль у розвитку цього захворювання?

- A. Наявність соматичних захворювань
- B. Куріння сигарет
- C. Зниження реактивності організму
- D. Нераціональне харчування
- E. Фузоспірилярна інфекція

54. Жінці віком 46 років планується виготовити суцільнокерамічні коронки з опорою на 12, 11 зуби. Після препарування опорних зубів було виготовлено провізорні коронки

прямим методом. На який цемент їх треба зафіксувати?

- А. Полікарбоксилатний
- В. Цинк-оксидний без евгенолу
- С. Склоіономерний
- Д. Цинк-оксидний з евгенолом
- Е. Цинк-фосфатний

55. На амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі, під час видалення 16 зуба, пацієнт віком 22 роки раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: реакція зіниць на світло відсутня, шкіра та видимі слизові оболонки ціанотичні. Відбувається неконтрольоване пошмикування рук та ніг, періодичні повороти голови, прикушування язика. З рота виділяється піниста слина. Який невідкладний стан розвинувся в пацієнта?

- А. Гіпертонічний криз
- В. Анафілактичний шок
- С. Напад бронхіальної астми
- Д. Інфаркт міокарда
- Е. Епілептичний напад

56. Хлопець віком 20 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці верхнього зуба мудрості ліворуч, травмування щоки під час жування. Об'єктивно спостерігається: 28 зуб прорізався в щічному напрямку та розташований поза зоною оклюзійних співвідношень. Показано видалення 28 зуба. Рентгенологічно виявлено тонкий рівень кісткової тканини навколо нього у вестибулярному напрямку. Яку методику найдоцільніше застосувати для попередження ускладнень під час видалення зуба?

- А. Аатравматичне видалення за допомогою п'єзотому
- В. Використання періотому з пікоподібною насадкою
- С. Видалення багнетоподібними щипцями з люксаційними рухами
- Д. Використання елеваторів із товстими щічками
- Е. Застосування фізіодиспенсера для пренапрування кісткової тканини

57. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на утруднене вживання їжі через травмування слизової оболонки альвеолярного відростка нижньої щелепи під час користування бюгельним протезом. Протез виготовлено тиждень тому. Після зняття протеза на рівні перехідної складки в ділянці відсутніх 45, 46 зубів із язикового боку виявлено болючу виразку розміром 1,5х3 мм з нерівними краями, що кровоточить від дотику. Яка виразка, ймовірно, спостерігається?

- А. Декубітальна
- В. Туберкульозна
- С. Сифілітична
- Д. Актиномікотична
- Е. Трофічна

58. Чоловіку віком 59 років показано видалення 28 зуба. Під час проведення провідникового знеболювання розчином Ультракаїну Д-С форте 1,7 мл, пацієнт зблід, відчув слабкість, запаморочення, загруднинний стискальний біль, який поширився на ліву руку. З'явилася задишка. АТ — 90/60 мм рт. ст. Пульс ниткоподібний. Після приймання нітрогліцерину загальний стан пацієнта покращився. Який невідкладний стан розвинувся в пацієнта?

- А. Стенокардія
- В. Анафілактичний шок
- С. Колапс
- Д. Інфаркт міокарда
- Е. Напад бронхіальної астми

59. Який із нижченаведених антибіотиків не порушує процес формування зубної тканини і не призводить до виникнення гіпоплазії зубів під назвою «тетрациклінові зуби»?

- А. Ампіциліну тригідрат
- В. Доксицикліну гідрохлорид
- С. Тайгециклін
- Д. Метацикліну гідрохлорид
- Е. Міноцикліну гідрохлорид

60. Чоловік віком 38 років звернувся до університетської стоматологічної поліклініки зі скаргами на постійний біль у ділянці верхньої щелепи праворуч. Після проведення комплексного обстеження встановлено діагноз: загострення хронічного гранулюючого періодонтиту 18 зуба, що стало показом до його видалення. У процесі екстракції прямим елеватором виник відлом горба верхньої щелепи. До чого може призвести це ускладнення?

- А. Парезу лицевого нерва
- В. Невралгії трійчастого нерва
- С. Деформації верхнього зубного ряду
- Д. Перелому верхньої щелепи
- Е. Емфіземи обличчя

61. Чоловік віком 43 роки скаржиться на болючу припухлість правої половини обличчя, болісне та обмежене відкривання рота, підвищення температури тіла до 39°C, погіршення загального стану. З анамнезу відомо, що тиждень тому почав турбувати крайній зуб на верхній щелепі праворуч. За останню добу стан різко погіршився. Під час обстеження виявлено набряк м'яких тканин щічної та нижнього відділу скроневої ділянки, біль за горбом верхньої щелепи. Установіть попередній діагноз.

- А. Флегмона підскронсової ямки
- В. Флегмона крило-піднебінної ямки
- С. Флегмона виличної ділянки
- Д. Флегмона очної ямки
- Е. Флегмона скронсової ділянки

62. Жінці віком 56 років планується виготовлення керамічних коронок з опорою на раніше встановлені імплантати. Було проведено припасування індивідуальної ложки. Які конструкційні елементи потрібно встановити на імплантати перед зняттям відбитка?

- А. Гвинти заглушки
- В. Абатменти
- С. Формувачі ясен
- Д. Трансфери
- Е. Провізорні коронки

63. Пацієнт віком 48 років перебуває на стаціонарному лікуванні в щелепно-лицевому відділенні протягом місяця з діагнозом: флегмона піднижньощелепної ділянки. Отримує стандартну для цього захворювання схему лікування. Відзначається незначне покращення, але вздовж рани постійно утворюються нагнійні щільні інфільтрати з дрібними білуватими крупицями. Лікар провів додаткові дослідження, у результатах виявлено ксантомні клітини. Яке захворювання можна припустити в цьому разі?

- А. Бешиху
- В. Сифіліс
- С. Хворобу Боуена
- Д. Туберкульоз
- Е. Актиномікоз

64. Під час фіксації центрального співвідношення щелеп визначено умовний анатомічний орієнтир: лінію, яка проходить від точки на початку кісткової основи носової перегородки до середини козелка вуха. Як називається цей орієнтир?

- А. Сагітальна крива Шпее
- В. Трансверзальна крива Уілсона
- С. Камперівська горизонталь
- Д. Франкфуртська горизонталь
- Е. Оклопійна площина

65. Чоловік віком 29 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на локальний біль у ділянці кута нижньої щелепи, веретеноподібну деформацію щелепи, рухомість та випадіння здорових зубів із цього боку. З анамнезу відомо: у пацієнта хвороба Педжета. Установіть попередній діагноз.

- А. Остеосаркома нижньої щелепи
- В. Адамантинома нижньої щелепи
- С. Рак нижньої щелепи
- Д. Парадентальна кіста
- Е. Остеобластокластома нижньої щелепи

66. У семирічної дівчинки під час огляду лікарем-стоматологом виявлено каріозну порожнину на жувальній поверхні 74 зуба. Установлено діагноз: гострий глибокий карієс 74 зуба, І клас за Блемом. Який пломбувальний матеріал в якості постійної пломби є найдоцільнішим у цьому разі?

- А. Водний дентин
- В. Склоіономерний цемент
- С. Композит
- Д. Силант
- Е. Компомер

67. Під час ендодонтичного лікування постійного зуба у хлопчика віком 15 років лікар-стоматолог для визначення робочої довжини кореневого каналу застосував апекслокатор. У яких випадках використання цього методу визначення робочої довжини є протипоказаним?

- А. Під час вторинного ендодонтичного лікування
- В. Лікування методом девітальної екстирпації
- С. Лікування зубів із несформованим коренем
- Д. Лікування зубів із облітерованими каналами
- Е. Лікування зубів мудрості

68. Під час стоматологічного огляду восьмирічної дівчинки на вестибулярних поверхнях різців обох щелеп виявлено білі плями без чітких меж, що поступово переходять у здорові тканини зубів. Лікарем встановлено попередній діагноз: флюорозу зубів. Що є головним фактором під час проведення диференціальної діагностики з гострим початковим карієсом зубів?

- А. Результат термопрови
- В. Час виникнення плям
- С. Дані ЕОД
- Д. Дані рентгенографії
- Е. Динаміка змін плям

69. Батьки восьмирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці верхньої щелепи ліворуч та підвищення температури тіла до 37,9°C у дитини. Дівчинка хворіє другу добу. Об'єктивно спостерігається: асиметрія обличчя через припухлість лівої щоки, коронкова частина 65 зуба зруйнована на 1/2, перкусія його різко болісна, гіперемія та набряк слизової оболонки з вестибулярного боку альвеолярного відростка на рівні 64, 65 та 26 зубів, під час пальпації визначається флюктуація. Який імовірний діагноз?

- A. Одонтогенний гайморит
- B. Одонтогенна кіста верхньої щелепи
- C. Загострення хронічного періодонтиту 65 зуба
- D. Гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи
- E. Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи

70. Жінка віком 25 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність пухирців на червоній облямівці нижньої губи. Напередодні було підвищення температури тіла до 38,5°C. Із анамнезу відомо: протягом останніх років ці симптоми виникають періодично приблизно раз на півроку. Під час огляду на червоній облямівці нижньої губи виявлено дрібні пухирці, що розміщені групою, заповнені мутною рідиною, болючі під час пальпації. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні. Які лікарські засоби треба призначити для місцевого лікування?

- A. Антибіотики
- B. Знеболювальні
- C. Протівірусні
- D. Кератопластики
- E. Антимікотичні

71. Пацієнту віком 23 роки планується виготовити металокерамічну коронку на 46 зуб у зв'язку із дефектом твердих тканин зуба. З якою метою під час препарування 46 зуба лікар-стоматолог-ортопед сформував скошений уступ?

- A. Профілактика захворювань тканин пародонта
- B. Покращення ретенції коронки
- C. Попередження сколів
- D. Естетичність конструкції
- E. Раціональність навантаження

72. Чоловік віком 52 роки звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда зі скаргами на часте випадіння пломби в зубі на верхній щелепі праворуч. Об'єктивно спостерігається: 15 зуб зруйнований, кукса зуба виступає на 2 мм над яснами. На рентгенограмі кореневий канал запломбовано до рівня фізіологічної верхівки, периапікальних змін не виявлено. Пацієнту запропоновано виготовлення литої куксово-кореневої вкладки та металокерамічної коронки. Що допоможе попередити перелом кореня опорного зуба?

- A. Зменшення навантаження
- B. Наявність ферул-ефекту в зубі
- C. Анатомічна форма коронки
- D. Фіксація куксової вкладки
- E. Пломбування кореневого каналу

73. Дівчина віком 18 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний недолік зубів через підвищену кількість нальоту на них. Об'єктивно спостері-

гається: КПУ=7, пломби відповідають критеріям якості, але стан гігієни порожнини рота незадовільний. Пацієнтці проведено професійну гігієну порожнини рота та навчання правильній методиці чищення зубів із підбором засобів індивідуальної гігієни. Рекомендовано повторне відвідування через тиждень. Що має бути проведено під час повторного відвідування?

- A. Контрольоване чищення зубів
- B. Відбілювання зубів
- C. Бесіда про профілактику карієсу зубів
- D. Бесіда про профілактику захворювань пародонта
- E. Повторна професійна гігієна

74. Юнак віком 18 років скаржиться на біль у ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Зі слів пацієнта, він отримав побутову травму два дні тому. Об'єктивно спостерігається: садна в ділянці верхньої губи, зубний ряд інтактний, рухомість 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів I ступеня. Після рентгенологічного дослідження встановлено діагноз: перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи в ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів. Яку шину для постійної фіксації треба застосувати в цьому разі?

- A. Гладку шину-скобу
- B. Шину Порта
- C. Шину із зачіпними петлями
- D. Шину Лімберга
- E. Шину з розпірковим вигином

75. Жінка віком 37 років скаржиться на гострий постійний біль у зубі на нижній щелепі ліворуч, що посилюється від накупування. Із анамнезу відомо: чотири роки тому турбував гострий нападоподібний біль, що посилювався від температурних подразників, але пацієнтка до лікаря не зверталася. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 37 зуба частково збережена пломба, термопроба негативна, перкусія 37 зуба різко болісна. Слизова оболонка в ділянці проєкції верхівок коренів 37 зуба гіперемована, набрякла, болісна під час пальпації. Підщеленні лімфувузли збільшені, болісні. На рентгенограмі виявлено вогнище деструкції кісткової тканини в периапікальній ділянці коренів 37 зуба без чітких меж. Який імовірний діагноз?

- A. Гострий серозний періодонтит
- B. Гострий гнійний періодонтит
- C. Гострий дифузний пульпіт
- D. Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту
- E. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту

76. Чоловік віком 50 років скаржиться на наявність новоутворення на верхній губі. Об'єктивно на шкірі верхньої губи спостерігається одиночний вузол гіперкератозу, що підвищується над рівнем приле-

глих тканин, конічної форми, діаметром 0,4 см, безболісний під час пальпації, сірого кольору, має пошарову будову. Установіть попередній діагноз.

- A. Кератоакантома
- B. Шкірний ріг
- C. Хвороба Боуена
- D. Бородавчастий передрак
- E. Папілома

77. У пацієнта виявлено недорозвинення правої половини верхньої та нижньої щелеп, виличної дуги та виличної кістки, поперечна щілина обличчя, недорозвинена вушна раковина, незначний привісок біля козелка вуха праворуч. Для якого синдрому характерні ці клінічні ознаки?

- A. Костена
- B. Педжета
- C. I та II зябрових дуг
- D. Робена
- E. Реклінгхаузена

78. Жінка віком 57 років скаржиться на погіршення загального стану, сильний головний біль, підвищення температури тіла до 39°C, появу нудоти, блювання, задишки. На обличчі виявлено ділянки вираженого почервоніння шкіри з чіткими нерівними обрисами, що підвищуються над рівнем прилеглих тканин. Шкіра уражених ділянок різко болісна, набрякла, ущільнена, гаряча на дотик, гладенька та блискуча. Піднижньощелепні лімфатичні вузли збільшені. Який імовірний діагноз?

- A. Стрептодермія
- B. Бешіа
- C. Червоний вовчак
- D. Тромбофлебіт лицевої вени
- E. Сибірка

79. У чоловіка віком 52 роки на шкірі правої щоки спостерігається щільна, болюча, конічної форми ділянка запалення з гнійно-некротичним стрижнем всередині. Який імовірний діагноз?

- A. Фурункул
- B. Сибірка
- C. Бешіа
- D. Нома
- E. Карбункул

80. Батьки шестирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу в дитини проміжків між зубами. Під час обстеження виявлено тріщини та діастеми між зубами та стертість ріжучих країв та горбиків. Що можна запропонувати цьому пацієнту?

- A. Міогімнастику
- B. Вибіркове прищілювання
- C. Не потребує лікування
- D. Апаратурне лікування
- E. Не вживати тверду їжу

81. Жінка віком 53 роки звернулася зі скаргами на новоутворення на нижній губі з орального боку, що з'явилося місяць тому та збільшується в розмірах. Об'єктивно спостерігається: у товщі нижньої губи утворення округлої форми, еластичне, напівпрозоре, безболісне, до 0,6 см у діаметрі. Слизова оболонка в кольорі не змінена. Який попередній діагноз?

- A. Абсцес губи
- B. Ретенційна кіста
- C. Фіброма
- D. Папілома
- E. Ліпома

82. Хлопець віком 16 років скаржиться на самовільний, іррадіючий, пульсуючий біль у ділянці верхньої щелепи ліворуч, що різко посилюється від гарячого, виник вперше три дні тому. Об'єктивно спостерігається: на медіально-контактній поверхні 27 зуба каріозна порожнина, що заповнена світлим розм'якшеним дентином та не сполучається з пульповою камерою зуба. Зондування дна каріозної порожнини майже безболісне, горизонтальна перкусія болісна. Термопроба холодним подразником зменшує інтенсивність болю. Який попередній діагноз?

- A. Гострий обмежений пульпіт
- B. Гострий гнійний періодонтит
- C. Гострий гнійний пульпіт
- D. Загострення хронічного періодонтиту
- E. Загострення хронічного пульпіту

83. У пацієнта виявлено недорозвинення нижньої щелепи, щілина твердого та м'якого піднебіння, глосоптоз. Який синдром можна діагностувати в цьому разі?

- A. Горліна-Гольтца
- B. Гольденхара
- C. Робена
- D. Костена
- E. Шегрена

84. У чоловіка віком 40 років діагностовано дефект зубного ряду II класу за Кеннеді: на нижній щелепі ліворуч відсутні зуби до 34 включно. 33 зуб інтактний, стійкий, клінічна коронка висока. Який протез є найраціональнішим у цьому разі?

- A. Бюгельний з кламерною фіксацією
- B. Бюгельний із замковим кріпленням
- C. Мостоподібний з опорою на імплантати
- D. Консольний металокерамічний мостоподібний
- E. Частковий знімний пластинковий

85. Жінка віком 64 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль під час вживання їжі, висипи на слизовій оболонці порожнини рота та неприємний запах із рота. Після обстеження встановлено діагноз: вульгарна пухирчатка. Які клітини виявлено в цитологічному дослідженні?

- A. Лангерганса
- B. Тцанка
- C. Березовського-Штернберга
- D. Мікуліча
- E. Атипові

86. Під час одержання відбитка альгінатною масою з верхньої щелепи в пацієнта раптово виникли прискорене та поглиблене дихання, збудження, пітливість. Лікар негайно нахилив голову пацієнта донизу та виявив відбиткову ложку з відбитковою масою, але шматок альгінатної маси потрапив у верхні дихальні шляхи. Шкірні покриви пацієнта набули сірого забарвлення, а губи — ціанотичного відтінку. Який невідкладний захід треба здійснити до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- A. Оксигенотерапію
- B. Серцево-легеневу реанімацію
- C. Конікотомію
- D. Прийом Геймліха
- E. Ударити долонею між лопатками

87. Дванадцятирічна дівчинка хворіє другий день. Спостерігається підвищення температури тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$, загальна слабкість. Під час огляду ротової порожнини виявлено плями Філатова-Копліка-Бельського на слизовій оболонці щік, у ділянці постійних верхніх молярів, що не знімаються тампоном. Ознакою якого захворювання є ці плями?

- A. Стоматиту Сеттона
- B. Вітряної віспи
- C. Інфекційного мононуклеозу
- D. Кору
- E. Синдрому Бехчета

88. Чоловіка віком 45 років шпиталізовано до лікарні з місця ДТП із діагнозом: забійно-рвана рана щоки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. До яких травм належать ці пошкодження?

- A. Комбінованих
- B. Поєднаних
- C. Ізольованих
- D. Поодиноких
- E. Множинних

89. Жінка віком 49 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття стягнутості щік, особливо вранці, та зниження смакової чутливості. Об'єктивно спостерігається: на слизовій оболонці

щік у ретромоларній ділянці, язиці, губах та яснах є полігональні папули, що зливаються між собою, утворюючи малюнок білого кольору у вигляді мережива. Папули чітко обмежені, безболісні та добре пальпуються. Під час пальпації регіонарних лімфовузлів патологічних змін не виявлено. Який імовірний діагноз?

- A. Червоний вовчак
- B. Червоний плоский лишай
- C. Вторинний сифіліс
- D. Лейкоплакія
- E. Кандидозний стоматит

90. Дитина грудного віку хворіє протягом двох днів. Вона неспокійна, вередує під час їжі, температура тіла в межах норми. Об'єктивно спостерігається: на яскраво гіперемованій та набряклій слизовій оболонці щік та спинці язика сироподібний наліт білого кольору. Після його видалення оголюється яскраво гіперемована поверхня слизової з точковими крововиливами. Який імовірний діагноз?

- A. Гострий кандидозний стоматит
- B. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- C. Гострий герпетичний стоматит
- D. М'яка форма лейкоплакії
- E. Стоматит Венсана

91. Чоловік віком 69 років скаржиться на прогресуючу асиметрію обличчя, парез м'язів обличчя. Під час огляду виявлено новоутворення в привушній ділянці праворуч попереду мочки вуха без чітких меж, до 7 см у діаметрі, спаяне з прилеглими тканинами. Який попередній діагноз?

- A. Аденокарцинома
- B. Змішана пухлина
- C. Псевдопаротит Герценберга
- D. Атерома
- E. Ліпома

92. Під час проведення операції видалення зуба пацієнт випадково вдихнув марлевий тампон. Виникло різке порушення дихання, кашель. Яка асфіксія розвивається в цьому разі?

- A. Стенотична
- B. Аспіраційна
- C. Дислокаційна
- D. Обтураційна
- E. Клапанна

93. Батьки восьмирічної дівчинки скаржаться на болісність та кровоточивість ясен у дитини. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен верхньої та нижньої щелепи у ділянці фронтальних зубів та перших постійних молярів набрякла, гіперемована, ясенні сосочки мають заокруглену форму. Тимчасові зуби відсутні. Також спостерігається симетричне ураження до-

лоней та підонів у вигляді ділянок гіперкератозу коричневого кольору, що межують із зонами підвищеного злущування епідермісу. Для якого захворювання характерні ці клінічні симптоми?

- А. Хвороби Таратина
- В. Синдрому Папіона-Лефевра
- С. Хвороби Гюше
- Д. Пародонтального синдрому при цукровому діабеті
- Е. Хвороби Німана-Піка

94. Чоловік віком 54 роки після травми скаргиється на кровотечу з носа, порушення чутливості верхньої губи праворуч, деформацію обличчя, обмежене відкривання рота. Під час пальпації кісток лицьового скелета спостерігається симптом «сходінки» по нижньому краю орбіти та в ділянці вилично-альвеолярного гребеня праворуч. Рентгенологічно визначається завуальованість верхньощелепного синуса з правого боку. Який імовірний діагноз?

- А. Перелом верхньої щелепи по Лефор-III
- В. Перелом верхньої щелепи по Лефор-II
- С. Перелом кісток носа
- Д. Перелом верхньої щелепи по Лефор-I
- Е. Перелом виличної кістки праворуч

95. Жінка віком 25 років наприкінці III триместру вагітності звернулася до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду. Після проведення професійної гігієни лікар провів бесіду щодо подальших заходів профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтки та майбутньої дитини. Що є найкращим способом постнатальної профілактики карієсу зубів у дітей?

- А. Регулярне професійне чищення зубів у матері
- В. Регулярна санація порожнини рота матері
- С. —
- Д. Грудне вигодовування дитини
- Е. Збалансоване харчування матері

96. Чоловік віком 25 років скаргиється на печіння язика під час вживання кислої їжі. Об'єктивно спостерігається: на спинці язика виявлено ділянки десквамації, позбавлені ниткоподібних сосочків яскраво-червоного кольору, що оточені зроговілими ниткоподібними сосочками білого забарвлення. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хронічний кандидоз
- В. Вторинний сифіліс
- С. Десквамативний глосит
- Д. Ромбоподібний глосит
- Е. Туберкульозна виразка

97. До лікаря-стоматолога звернулися батьки дев'ятирічної дівчинки зі скаргами на біль у фронтальній ділянці верхньої щелепи та відсутність зуба в дитини через

травму обличчя під час спортивних змагань. Об'єктивно спостерігається: 11 зуб відсутній, 21 зуб зміщений у бік відсутнього 11 зуба. На рентгенограмі виявлено розширення періодонтальної щілини 21 зуба. Який імовірний діагноз?

- А. Вбитий вивих 11 зуба, повний вивих 21 зуба
- В. Повний вивих 21 зуба, перелом кореня 11 зуба
- С. Вбитий вивих 21 зуба, повний вивих 11 зуба
- Д. Повний вивих 11 зуба, неповний вивих 21 зуба
- Е. Неповний вивих 11 зуба, перелом коронки 21 зуба

98. Жінка віком 33 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття печії, оніміння та болю в язичі, що зникають під час вживання їжі. Об'єктивно спостерігається: обличчя пропорційне, регіонарні лімфатичні вузли не збільшені, визначається сухість у порожнині рота, слизова оболонка блідо-рожевого кольору без патологічних змін. Язик набряклий, має незначну кількість білого нальоту на корені. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хронічний атрофічний кандидоз
- В. Неврит язикового нерва
- С. Глосит Гюнтера-Міллера
- Д. Глосидинія
- Е. Десквамативний глосит

99. У пацієнта віком 52 роки під час профілактичного огляду лікарем-стоматологом виявлено: на червоній облямівці нижньої губи ділянка полігональної форми до 0,8 см, вкрита тонкими щільно розташованими лусочками сірувато-коричневого кольору. Під час пальпації вогнище ураження безболісне, м'яке в основі, не виступає над рівнем прилеглих тканин. Який імовірний діагноз?

- А. Хвороба Боуена
- В. Передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ
- С. Бородавчастий передрак
- Д. Лейкоплакія
- Е. Червоний плоский лишай

100. Дівчина віком 19 років звернулася до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний дефект. Об'єктивно спостерігається: губи не змикаються, верхня губа укорочена, між фронтальними зубами верхньої та нижньої щелеп сагітальна щілина. Відзначається скупчення фронтальної групи зубів нижньої щелепи. Яку аномалію розвитку виявлено у пацієнтки?

- А. Мікрогнатія
- В. Прогнатія
- С. Перехресний прикус
- Д. Відкритий прикус
- Е. Прогенія

101. Після обстеження пацієнта віком 83 роки лікар-стоматолог встановив попередній діагноз: фіброма щічної ділянки. Яка тактика лікування цього захворювання?

- А. Променева терапія
- В. Фізіотерапевтичні заходи
- С. Хіміотерапевтичне лікування
- Д. Видалення утворення
- Е. Протизапальна терапія

102. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на погіршення загального стану, підвищення температури тіла до $38,0^{\circ}\text{C}$ у дитини, відмову від вживання їжі. Об'єктивно спостерігається: явища катарального гінгівіту, на тлі гіперемії слизової оболонки порожнини рота поодинокі дрібні пухирці та ерозії овальної форми з вінчиком гіперемії, різко болючі від дотику. Який імовірний діагноз?

- А. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- В. Стоматит при корі
- С. Гострий герпетичний стоматит
- Д. Стоматит при вітряній віспі
- Е. Стоматит при краснусі

103. Чоловік віком 40 років скаржиться на біль у ділянці лівого слухового проходу та хрускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, пропорційне, рухи нижньої щелепи мають девіацію та викликають біль. Під час внутрішньоротової пальпації відчувається напруженість латеральних крилоподібних м'язів. На комп'ютерній томографії структури суглобових поверхонь рівні та гладкі, патологічних змін не виявлено. Який імовірний діагноз?

- А. Хронічний артрит СНЩС
- В. Дисфункція СНЩС
- С. Деформуючий артроз СНЩС
- Д. Ревматичний артрит СНЩС
- Е. Анкілоз СНЩС

104. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулися батьки шістнадцятирічної дівчинки зі скаргами на прикушування нею слизової оболонки щоки ліворуч, асиметрію обличчя. Під час обстеження виявлено незбіг серединних ліній та основ вуздечок верхньої та нижньої щелеп, невідповідність між шириною верхнього та нижнього зубних рядів. Яка клінічна функціональна проба Ільїної-Маркосян дозволить визначити зміщення нижньої щелепи?

- А. Перша та друга
- В. Перша та третя
- С. Перша та четверта
- Д. Друга та четверта
- Е. Третя та четверта

105. Чоловік віком 55 років під час стоматологічного прийому після проведення провідникового знеболювання розчином Септанеста з адреналіном 1/100000 1,7 мл поскаржився на сильний головний біль, запаморочення, шум у вухах, порушення зору, сухість у роті, нудоту, оніміння половини обличчя та кінцівок. Під час огляду виявлено: кут рота пацієнта зміщений донизу, мовлення змінене. Який невідкладний стан, імовірно, розвинувся в пацієнта?

- А. Анафілактичний шок
- В. Гіпоглікемічна кома
- С. Гіпертонічний криз
- Д. Інфаркт міокарда
- Е. Ішемічний інсульт

106. Чоловіку віком 53 роки проведено екстракцію 16 зуба внаслідок хронічного гранулематозного періодонтиту. На етапі кюретажу лунки проведено пальце-носову пробу, яка виявилася позитивною. Яка тактика лікаря-стоматолога-хірурга в цьому разі?

- А. Проведення пластичного ушивання
- В. Тампонада комірки гемостатичною губкою
- С. Антибіотикотерапія
- Д. Тампонада комірки йодоформною турундою
- Е. Проведення синус-ліфтингу

107. Під час профілактичного огляду одинадцятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив незначну гіперемію, інфільтрацію, сухість та лущення всієї поверхні червоної облямівки губ із порушенням їх архітекτονіки. Пацієнт скаржиться на сухість та відчуття стягнутості губ, особливо в холодні пори року. Який вид хейліту можна діагностувати в цьому разі?

- А. Метерологічний
- В. Ексфоліативний
- С. Атопічний
- Д. Мікробний
- Е. Алергійний

108. Жінка віком 43 роки скаржиться на появу безболісної симетричної червоної плями, розташованої в центральній частині обличчя, що охоплює щоки та крила носа. З анамнезу відомо, що подібні симптоми виникають періодично в осінньо-літній період. Під час обстеження на шкірі обличчя виявлено еритему, запала центральна частина якої вкрита лусочками, а по периферії — блідо-червона смужка вільна від лусочок з ділянками гіперкератозу різної величини та валиком папульозного інфіль-

трату. Установіть попередній діагноз.

- А. Хвороба Боуена
- В. Багатоформна ексудативна еритема
- С. Оперізувальний лишай
- Д. Червоний вовчак
- Е. Бешпах

109. У пацієнта з діагнозом: серцева недостатність II стадії — виявлено болісну виразку в ретромоларній ділянці порожнини рота ліворуч. Дно виразки вкрито фібринозним нальотом, запальний інфільтрат навколо виразки відсутній. Яка стоматологічна допомога доцільна в цьому разі?

- А. Хірургічне лікування
- В. Місцево глюкокортикостероїди
- С. Протигрибкове лікування
- Д. Антисептичні або антибактеріальні засоби
- Е. Місцеве знеболювання й репаранти

110. Під час профілактичного огляду десятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив на вестибулярній поверхні 11 зуба крейдоподібну блискучу пляму з чіткими межами, що не тьмяніє під час висушування. Решта зубів без змін. Установлено попередній діагноз: місцева гіпоплазія. Для проведення диференціальної діагностики лікар провів вітальне фарбування зони ураження. Який розчин для цього найчастіше використовують?

- А. Йоду
- В. Генціанвіолету
- С. Хлоргексидину
- Д. Еритрозинову
- Е. Метиленового синього

111. Жінка віком 40 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен та рухомість зубів, що турбують протягом декількох років. Для об'єктивізації стану тканин пародонта лікар вирішив провести пародонтальний скринінг-тест (PSR). Що є визначальним для встановлення ступеня тяжкості патології пародонта та визначення алгоритму подальшого ведення пацієнта?

- А. Ступінь рухомості зубів
- В. Кількість зубних відкладень
- С. Ступінь кровоточивості
- Д. Ступінь рецесії ясен
- Е. Глибина зондування

112. Жінці віком 72 роки виготовляють повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. На етапі визначення центрального співвідношення щелеп лікар наклав воскові шаблони з прикусними валиками в ротову порожнину та попросив пацієнтку ковтнути слину. Що допоможе зробити ця проба?

- А. Визначити міжальвеолярну висоту
- В. Правильно накреслити прикусні валики
- С. Визначити положення протетичної площини
- Д. Розмістити нижню щелепу в центричному положенні
- Е. Полегшити проведення процедури

113. Батьки дев'ятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність больових утворень у порожнині рота, підвищення температури тіла до 38,7°C, головний біль, підвищену слабкість у дитини. Під час огляду на набряклій, гіперемованій слизовій оболонці губ та щік виявлено великі ерозивні поверхні, що вкриті фібринозним нальотом. На червоній облямівці губ спостерігаються масивні кров'янисто-коричневого кольору тріщини, що кровоточать. На шкірі гомілки наявні вогнища ураження у вигляді папул рожево-червоного кольору з чіткими межами. Із анамнезу відомо: у пацієнтки медикаментозна алергія. Які лікарські засоби для етіотропного лікування треба призначити для лікування цього захворювання?

- А. Противірусні
- В. Протигрибкові
- С. Антисептичні
- Д. Антибактеріальні
- Е. Антигістамінні

114. Батьки восьмирічного хлопчика скаржаться на підвищення температури тіла до 38,5°C, млявість та біль у горлі дитини. Об'єктивно спостерігається: гострий катаральний стоматит, мигдалики набряклі, гіперемовані, укриті жовто-сірим нальотом, що легко знімається. Підщелепні, шийні, потиличні лімфовузли значно збільшені, слабо болючі під час пальпації. За результатами лабораторного дослідження виявлено лейкоцитоз і атипові мононуклеари. Укажіть етіологічний чинник захворювання.

- А. Вірус Епштейна-Барр
- В. Вірус простого герпесу
- С. Гемолітичний стрептокок
- Д. Вірус Коксаки
- Е. Паличка Борде-Жангу

115. Дівчина віком 16 років скаржиться на швидку втомлюваність, сонливість, млявість, запаморочення, головний біль, ламкість волосся та нігтів, парестезії язика після вживання гострої та солоної їжі, спотворення смакових відчуттів, сухість у роті. Об'єктивно спостерігається: блідість та сухість шкірних покривів, слизова оболонка порожнини рота бліда, суха. Язик набряклий, сосочки його атрофовані. Результати дослідження периферичної крові: гемоглобін — 80 г/л, еритроцити — $3,2 \cdot 10^{12}/л$, КР — 0,75. Який діагноз можна припустити в цьому разі?

- A. Гіповітаміноз С
- B. Залізодефіцитна анемія
- C. Кандидозний стоматит
- D. Гіповітаміноз групи В
- E. Перніціозна анемія

116. Дівчина віком 16 років скаржиться на кровоточивість та болючість ясен. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен набрякла, гіперемована, ясенні сосочки вкриті сірим некротичним нальотом. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації. Який імовірний діагноз?

- A. Атрофічний гінгівіт
- B. Локалізований пародонтит
- C. Гіпертрофічний гінгівіт
- D. Катаральний гінгівіт
- E. Виразковий гінгівіт

117. Жінка віком 25 років, якій три доби тому видалено 36 зуб, скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до 38,1°C. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка бліда, обличчя асиметричне через припухлість м'яких тканин у ділянці нижньої щелепи з лівого боку, парестезія нижньої губи ліворуч, відкриття рота утруднене, альвеолярний відросток у ділянці 36 зуба муфтоподібно потовщений, слизова оболонка набрякла, гіперемована. Із лунки 36 зуба виділяється гній. Який імовірний діагноз?

- A. Нагноєння радикулярної кістки нижньої щелепи
- B. Флегмона підщелепної ділянки
- C. Гострий остеомієліт нижньої щелепи
- D. Гострий періостит нижньої щелепи
- E. Гострий гнійний лімфаденіт

118. На прийомі в лікаря-стоматолога під час препарування зубів жінка віком 49 років поскаржилася на слабкість, головокружіння, озноб. Об'єктивно спостерігається: свідомість збережена, шкірні покриви бліді, вкриті холодним потом, дихання поверхневе, прискорене, пульс слабкий, АТ — 80/40 мм рт. ст. Який невідкладний стан, найімовірніше, розвинувся в пацієнтки?

- A. Непритомність
- B. Гіпертонічний криз
- C. Анафілактичний шок
- D. Судинний колапс
- E. Больовий шок

119. Чоловік віком 23 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на інтенсивний нападоподібний біль у зубі на нижній щелепі ліворуч, що з'явився напередодні ввечері. Об'єктивно спостерігається: на медіально-контактній поверхні 37 зуба каріозна порожнина, що заповнена розм'якшеним світлим дентином та не сполучається з пульповою камерою зуба. Зондування каріозної порожнини болісне в одній

точці. Перкусія 37 зуба безболісна. Холодовий подразник провокує довготривалий больовий напад. Який попередній діагноз?

- A. Гострий обмежений пульпіт
- B. Загострення хронічного пульпіту
- C. Гострий серозний періодонтит
- D. Гострий дифузний пульпіт
- E. Гострий гнійний пульпіт

120. Під час боксування спортсмен віком 17 років отримав удар у фронтальну ділянку верхньої щелепи, у результаті якої було повністю вибито два верхні центральні різці. Об'єктивно спостерігається: їхні комірки заповнені кров'яними згустками, стінки збережені, слабо болісні під час пальпації. Який метод лікування найдоцільніший у цьому разі?

- A. —
- B. Резекція верхівок коренів 11 та 21 зубів
- C. Негайна реплантація зубів
- D. Віддалена імплантація
- E. Ушивання рани кетгутотом

121. Пацієнт віком 56 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах із рота та рухомість зубів, що турбують протягом п'яти років. Після проведених клінічних та додаткових методів дослідження лікар встановив діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня, і запропонував план лікування. Яка основна мета лікування пародонтиту?

- A. Усунення оклюзійної травми
- B. Стимулювання регенерації
- C. Усунення запалення ясен
- D. Видалення зубної бляшки
- E. Досягнення стабілізації процесу

122. Чоловік віком 69 років скаржиться на біль під час вживання їжі, застрягання їжі в зубі на верхній щелепі ліворуч. З анамнезу відомо: у пацієнта гіпертонічна хвороба, перенесений інфаркт міокарда 7 місяців тому. Об'єктивно спостерігається: на дистально-апроксимальній поверхні 26 зуба глибока каріозна порожнина, що не сполучається з пульповою камерою зуба. Зондування дна порожнини безболісне, термпроба болісна, біль зникає одразу після усунення подразника. Який анестетик із нижченаведених є препаратом вибору під час лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою в анамнезі?

- A. Артикаїн
- B. Бупівакаїн
- C. Лідокаїн
- D. Новокаїн
- E. Мепівакаїн

123. У шестирічній дівчинки діагностовано остеомієліт кута нижньої щелепи праворуч. До ризику виникнення якої аномалії в

майбутньому може призвести це захворювання?

- А. Макрогенії
- В. Відкритого прикусу
- С. Мікрогенії
- Д. Дистального прикусу
- Е. Перехресного прикусу

124. Чоловік віком 67 років звернувся до лікаря-стоматолога для ортопедичного лікування. Об'єктивно спостерігається: повна відсутність зубів на нижній щелепі, значна, рівномірна атрофія альвеолярної частини, прикріплення м'язів, складок слизової оболонки, рухомих тяжів, вуздечок нижньої губи та язика на рівні верхівки альвеолярного гребеня, слизова оболонка суха на дотик, потоншена, атрофічна. Присінок ротової порожнини практично відсутній. Якому методу спеціальної підготовки ротової порожнини до протезування треба надати перевагу в цьому разі?

- А. Альвеолотомії
- В. Тканинній регенерації
- С. Френулопластиці
- Д. Дентальній імплантації
- Е. Вестибулопластиці

125. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігається: прикус ортогнатичний, коронка 36 зуба зруйнована карієсом більше ніж на 1/2, зубоальвеолярне подовження в ділянці 26 зуба з альвеолярним відростком, що виступає на 3 мм. Гігієна задовільна, тканини пародонта здорові. Виберіть найраціональніший план реабілітації в цій клінічній ситуації.

- А. Депульпування 25, 26 зубів, виготовлення зустрічних коронок на 25, 26, 36 зуби
- В. Інтрюзія 26 зуба за рахунок мініімплантів між 26, 27 зубами з покриттям коронкою 36 зуба
- С. Інтрюзія 26 зуба за рахунок мініімплантів між 25, 26 зубами з реставрацією коронки 36 зуба
- Д. —
- Е. Видалення 26 зуба з наступною імплантацією та протезуванням, покриття коронкою 36 зуба

126. Чоловік віком 30 років скаржиться на наявність у порожнині рота виразок, що з'являються періодично 1-2 рази на рік. Об'єктивно спостерігається: на слизовій оболонці нижньої губи та під язиком 2 ерозії округлої форми розміром 5-7 мм, оточені обідком запальної гіперемії, укриті сирувато-білим нальотом, різко болісні під час дотику. Який імовірний діагноз?

- А. Багатоформна ексудативна еритема
- В. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- С. Стоматит Сеттона
- Д. Первинний сифіліс
- Е. Рецидивний герпес

127. Батьки шестирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду порожнини рота дитини. Об'єктивно спостерігається: порожнина рота санована, КПВ+кп=6, 36 та 46 зуби повністю прорізалися, їх фісури інтактні, непігментовані, закриті. Який з методів профілактики карієсу буде найдоцільнішим у цьому разі?

- А. Неінвазивна герметизація фісур
- В. Диспансерний нагляд
- С. Аплікації фторвмісним гелем
- Д. Аплікації фторвмісним лаком
- Е. Інвазивна герметизація фісур

128. Жінка віком 35 років перебуває в інфекційному відділенні лікарні з приводу лікування грипу. Скаржиться на сухість та печіння слизової оболонки порожнини рота. Під час огляду на тлі гіперемованої слизової оболонки порожнини рота виявлено ділянки десквамації епітелію. Лікар-стоматолог призначив терапію. Який препарат здатний стимулювати місцевий імунітет, відновлення нормальної мікрофлори порожнини рота, бере участь у процесі регенерації та загоєнні ран порожнини рота?

- А. Діоксидин
- В. Хлоргексидин
- С. Перекис водню
- Д. Повідон-йод
- Е. Лізоцим

129. У чоловіка віком 42 роки під час огляду лікар-стоматолог виявив збільшення ниткоподібних сосочків язика зі зроговінням різного ступеня. Пацієнт скаржиться на присмак заліза у роті. Після обстеження встановлено діагноз: чорний волосатий язик. Які лікарські засоби доцільно застосувати в цьому разі?

- А. Кератопластичні
- В. Вітаміни
- С. Кератолітичні
- Д. Антисептики
- Е. Противірусні

130. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу на язиці болючої виразки. Об'єктивно спостерігається: на бічній поверхні язика ліворуч візуалізується виразка з підритими краями та брудно-сірим дном, розміром 1x2 см, болюча під час пальпації. Пальпуються збільшені підщелепні та шийні лімфатичні вузли. Який збудник, найімовірніше, спричинив захворювання?

- А. Ентеровірус Коксаки
- В. Паличка Леффлера
- С. Вірус простого герпесу
- Д. Паличка Коха
- Е. Гриби роду *Candida*

131. Чоловік віком 25 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект через наявність плям на фронтальних зубах верхньої щелепи. Із анамнезу відомо: плями з'явилися одразу після прорізування зубів. Об'єктивно спостерігається: на вестибулярній поверхні 11 та 21 зубів наявні коричневі плями неправильної форми. Термометрія безболісна. Яка з нижченаведених конструкцій буде найдодільнішою в цьому разі?

- А. Металокерамічні коронки
- В. Металопластмасові коронки
- С. Пластмасові коронки
- Д. Керамічні коронки
- Е. Вініри

132. Пацієнтка віком 47 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та почервоніння в ділянці металокерамічного мостоподібного протеза, виготовленого 2 місяці тому, після фіксації якого з'явилися вищенаведені скарги. Об'єктивно спостерігається: у ділянці проміжної частини мостоподібного протеза з опорою на 43 і 46 зуб слизова оболонка гіперемована, набрякла, місцями пошкоджена, кровоточить від дотику. Якої помилки припустилися під час виготовлення протеза?

- А. Перевантаження опорних зубів
- В. Неякісне лиття металевго каркаса
- С. Неправильне моделювання проміжної частини
- Д. Неправильне моделювання горбиків штучних зубів
- Е. Відсутність множинних оклюзійних контактів

133. У пацієнта віком 26 років, який захворів 3 дні тому, спостерігається підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, загальна слабкість. Під час огляду на шкірі тильної поверхні верхніх кінцівок виявлено чітко відмежовані округлі папули рожевого кольору, у порожнині рота численні ерозії, кров'яністі кірки на губах. Симптом Нікольського негативний. Який попередній діагноз?

- А. Пухирчатка
- В. Червоний плоский лишай
- С. Гострий герпетичний стоматит
- Д. Стоматит Венсана
- Е. Багатоформна ексудативна еритема

134. Тринадцятирічний хлопчик скаржиться на естетичний дефект у вигляді плям на верхньому передньому зубі. Об'єктивно спостерігається: на емалі вестибулярної поверхні в ділянці ріжучого краю 21 зуба

пляма білого кольору з чіткими межами, гладка під час зондування. Під час висушування пляма в розмірах не змінюється. Установіть попередній діагноз.

- А. Системна гіпоплазія емалі
- В. Місцева гіпоплазія емалі
- С. Гострий початковий карієс
- Д. Ендемічний флюороз
- Е. Хронічний поверхневий карієс

135. Чоловік віком 40 років скаржиться на самовільний нападоподібний гострий біль, що іррадіює за проекцією гілок трійчастого нерва. Біль може виникати під час їзди у транспорті, занять фітнесом. На ортопантограмі виявлено гомогенну тінь у пульповій камері 26 зуба. Оклюзійна поверхня 26 зуба стерта, ЕОД — 40 мкА. Який імовірний діагноз?

- А. Невралгія трійчастого нерва
- В. Гострий одонтогенний гайморит
- С. Хронічний конкрементозний пульпіт
- Д. Неврит трійчастого нерва
- Е. Загострення хронічного періодонтиту

136. В одинадцятирічного хлопчика діагностовано гострий серозний дифузний пульпіт 34 зуба. Під час рентгенологічного дослідження виявлено, що корінь 34 зуба перебуває у стадії несформованої верхівки. На якій основі має бути матеріал для пломбування кореневого каналу?

- А. Гідроксиду кальцію
- В. Евгенолу
- С. Резорцин-формаліну
- Д. Епоксидної смоли
- Е. —

137. Пацієнт віком 45 років скаржиться на наявність білої плями на щоді, яку помітив близько двох місяців тому. Об'єктивно спостерігається: на слизовій оболонці щоді по лінії змикання зубів ділянка білуватого кольору із чіткими краями, що не виступає над рівнем слизової оболонки, під час зіскрібання не знімається. Пальпація безболісна. Прилегла слизова оболонка не змінена. Який імовірний діагноз?

- А. Обмежений передраковий гіперкератоз
- В. Хронічний гіперпластичний кандидоз
- С. Червоний вовчак
- Д. Лейкоплакія
- Е. Червоний плоский лишай

138. Хлопець віком 18 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у порожнині рота, підвищення температури тіла до $37,4^{\circ}\text{C}$. Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота в ділянці піднебіння та щік виявлено болючі ерозії розміром $1,5 \times 0,5$ см. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. На шкірних покривах рук, тулуба та волосистої частини голови наявні плямисто-

папульні везикульозні висипи. Установіть попередній діагноз.

- A. Вітряна віспа
- B. Оперізувальний лишай
- C. Кір
- D. Скарлатина
- E. COVID-19

139. Дівчина віком 17 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на косметичний дефект через відсутність верхнього переднього зуба. З анамнезу відомо, що 22 зуб видалено місяць тому через травму. Об'єктивно спостерігається: відсутній 22 зуб, коронки зубів, що обмежують дефект, інтактні з добре вираженим скватором, мають високу коронкову частину. Прикус ортогнатичний. Яка ортопедична конструкція є найраціональнішою в цьому разі?

- A. Знімний протез із утримувальними кламерами
- B. Металокерамічна коронка на імплантаті
- C. Бюгельний протез
- D. Адгезивний мостоподібний протез
- E. Знімний протез із денто-альвеолярними кламерами

140. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на постійний пульсуючий, іррадіюючий біль у зубі нижньої щелепи ліворуч, що посилюється під час накушування, відчуття «вирослого» зуба. Біль виник три дні тому. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 36 зуба каріозна порожнина, що не сполучається з пульповою камерою зуба. Зондування та термодіагностика безболісні, перкусія різко болісна. Слизова оболонка перехідної складки в ділянці проєкції коренів 36 зуба набрякла, гіперемована, болісна під час пальпації. На рентгенограмі деструктивних змін кісткової тканини біля верхівок коренів 36 зуба не виявлено. Який імовірний діагноз?

- A. Гострий гнійний пульпіт
- B. Загострення хронічного періодонтиту
- C. Гострий серозний періодонтит
- D. Загострення хронічного пульпіту
- E. Гострий гнійний періодонтит

141. Під час огляду лікарем-стоматологом чоловік віком 54 роки поскаржився на загальну слабкість, головний біль, нудоту та біль у животі, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: пацієнт млявий, обличчя бліде без ознак ціанозу, губи, язик, шкіра сухі. Дихання сповільнене, глибоке, типу Куессмауля. У повітрі, що видихається, відчутний різкий запах ацетону. Тонус м'язів знижений, очні яблука м'які, АТ — 90/50 мм рт. ст. Який патологічний стан, імовірно, розвивається у пацієнта?

- A. Гіпоглікемічна кома
- B. Колапс
- C. Анафілактичний шок
- D. Епілептичний напад
- E. Гіперглікемічна кома

142. Жінка віком 23 роки на 7-му тижні вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на різкий біль у зубі верхньої щелепи ліворуч від холодних подразників, що триває декілька хвилин. Діагностовано гострий обмежений пульпіт 24 зуба. Який знеболювальний засіб треба застосувати для проведення анестезії в цьому разі?

- A. Новокаїн
- B. Лідокаїн
- C. Мепівакаїн
- D. Артикаїн
- E. Бупівакаїн

143. Дівчина віком 16 років скаржиться на кровоточивість під час вживання їжі в ділянці верхньої щелепи ліворуч. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 26 зуба каріозна порожнина, заповнена грануляційною тканиною червоного кольору. Глибоке зондування викликає різкий біль та кровоточивість. Перкусія зуба безболісна. Якому захворюванню відповідають ці клінічні симптоми?

- A. Гігантоклітинний гранульомі
- B. Хронічному гіпертрофічному пульпіту
- C. Хронічному гіпертрофічному гінгівіту
- D. Хронічному фіброзному пульпіту
- E. Хронічному гангренозному пульпіту

144. Чоловік віком 30 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на постійний ниючий біль у зубі, що посилюється під час накушування. Біль турбує дві доби. Раніше зуб був лікований з приводу карієсу. Об'єктивно спостерігається: 26 зуб сірого кольору, на жувальній поверхні велика композитна пломба з наявністю вторинного карієсу, термодіагностика та зондування негативні, перкусія болісна, пальпація в ділянці проєкції коренів болісна. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болючі. Яка доцільна лікувальна тактика в цьому разі?

- A. Пломбування каріозної порожнини із застосуванням кальцієвмісної прокладки
- B. Рентгендіагностика та ендодонтичне лікування
- C. Розтин по перехідній складці
- D. Призначення протизапальних препаратів
- E. Пришліфовування пломби

145. Пацієнтка віком 65 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємний запах із рота, відчуття печіння під частковим знімним протезом на верхній щелепі, що з'явилося за деякий час після його встановлення близько року тому. Об'єктивно спостерігається: протез вкритий товстим шаром нальоту, слизова обо-

лонка верхньої щелепи та твердого піднебіння гіперерована. Які найімовірніші причини виникнення скарг у пацієнтки?

- A.** Алергічна реакція на протез
- B.** Травматичне ушкодження слизової оболонки
- C.** Незадовільний гігієнічний догляд
- D.** «Парниковий ефект» під протезом
- E.** Недостатня фіксація знімного протеза

146. Чоловік віком 62 роки скаржиться на рухомість бічних зубів верхньої щелепи ліворуч, періодичний біль, відчуття тяжкості у правій половині верхньої щелепи, кров'янисті виділення з правої порожнини носа. Із анамнезу відомо: перші симптоми з'явилися 5 місяців тому, протягом останніх 10-ти днів біль посилюється, виникла загальна слабкість. Об'єктивно спостерігається: рухомість 16, 17, 18 зубів — II ступеня, пальпаторно виявлено відсутність кісткової стінки горба верхньої щелепи. На ОПТГ: гомогенне затемнення правої гайморової пазухи, деструкція її кісткових структур у вигляді цукру, що розчиняється. Який попередній діагноз?

- A.** Хронічний остеомієліт
- B.** Рак верхньої щелепи
- C.** Адамантинома верхньої щелепи
- D.** Остеобластокластома верхньої щелепи
- E.** Хронічний одонтогенний гайморит

147. Пацієнт віком 22 роки, який працює у дорожній службі, скаржиться на сухість, болісність, лущення губ у літній період. Об'єктивно спостерігається: червона облямівка губ набрякла, гіперерована, укрита дрібними лусочками та тріщинами. Який засіб доцільно призначити під час лікування для захисту червоної облямівки губ?

- A.** Антигістамінні препарати
- B.** Фотозахисну мазь
- C.** Зволожуючий гель
- D.** Протизапальні суспензії
- E.** Антисептичні розчини

148. Чотирнадцятирічна дівчинка скаржиться на відчуття стягування губ, які вона постійно облизує. Об'єктивно спостеріга-

ється: червона облямівка губ суха, набрякла та гіперерована, вкрита лусочками, що легко знімаються, оголюючи неушкоджену яскраво-червону поверхню. Визначте ймовірний вид хейліту.

- A.** Екзематозний
- B.** Атопічний
- C.** Метеорологічний
- D.** Ексфоліативний
- E.** Гландулярний

149. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулася мати десятирічної дівчинки зі скаргами на естетичний недолік у дитини. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, непропорційне через збільшення нижньої третини, рот напіввідкритий, губи в стані фізіологічного спокою не змикаються. Під час огляду порожнини рота виявлено: співвідношення перших постійних молярів нормогнатичне, між верхніми та нижніми центральними та латеральними різцями наявна вертикальна щілина 4 мм. Яка ортодонтична патологія в дитини?

- A.** Дистальний прикус
- B.** Відкритий прикус
- C.** Глибокий прикус
- D.** Звуження верхнього зубного ряду
- E.** Звуження нижнього зубного ряду

150. Дев'ятирічний хлопчик скаржиться на косметичний дефект. Під час внутрішньоротового обстеження виявлено, що перші постійні моляри змикаються за I класом Енгля, а між верхніми центральними різцями ширина щілини становить 2 мм, коронки різців нахилені латерально. Установлено діагноз: діастема на верхній щелепі. Який ортодонтичний апарат треба вибрати для лікування цієї патології?

- A.** Брекети-систему
- B.** Піднебінну пластинку з гвинтом для розширення верхнього зубного ряду
- C.** Піднебінну пластинку з рукоподібними кламерами
- D.** Апарат Андресена-Гойпля
- E.** Апарат Осадчого